

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	多發性硬化症 Multiple Sclerosis ; MS				
編號	A31000-Q03-W-A08	制定者	REH 張淑玲	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.8 版/11 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解多發性硬化症的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，對此疾病照護能有所依循，提供適切合宜之護理照護。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

多發性硬化症 (Multiple Sclerosis ; MS) 是中樞神經系統內神經髓鞘脫失 (demyelination)，致神經傳導無法迅速有效地傳送下去，進而導致局部或多處的神經功能異常，進而逐漸引發局部性或全身性反應。也有文獻指出多發性硬化症屬自體免疫疾病或病毒感染引起。

（二）症狀

患者多在 20-40 歲時發病，特別是 31-33 歲最為常見，女性的發生率約為男性的 4.4 倍，白種人的罹患率較為偏高，但兒童及老年人極為少見。東方人多發生在脊髓和視神經處；西方人則較常見在大腦。臨床症狀視其影響的神經組織而定，這些症狀可能會減輕或消失，消失後也可能再發作。由於 MS 是中樞神經系統髓鞘受損導致神經系統及肢體活動障礙，症狀出現各有不同，常見症狀為：複視、暈眩、疲倦、疼痛、痙攣、步態不穩、雙下肢偏癱、大小便控制困難等症狀，情緒認知方面產生無望、憂鬱等負面情緒。可能出現的症狀包括：

1. 疲勞：此為最常出現之症狀，會隨著疾病的進展，情況會越來越嚴重。

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/11

2. 視覺受損：視神經炎、視力模糊、複視、視野缺損、不自主的眼球跳動、嚴重者甚至失明。
3. 認知、情緒問題：記憶力、專注力、判斷力可能會有問題。
4. 平衡、協調問題：失去平衡感、顫抖、走路不穩、頭暈、四肢不靈活、身體喪失協調能力、運動功能受損。
5. 神經系統：會導致麻木、刺痛、灼熱感覺，特別是在手部及足部。或肢體痠痛、下肢或四肢偏癱、神經肌肉失調。
6. 肌肉方面：因肌肉痙攣或僵硬而影響活動力，間歇或永久的麻痺、肌肉無力，嚴重亦會影響呼吸肌肉群。
7. 感覺改變：會有麻木、刺痛、灼熱或其他難以形容的異常感覺。可能有顏面疼痛（三叉神經痛）、肢體痛、60-80%會有熱敏感。
8. 語言能力：講話速度變慢、發音模糊、講話節奏改變、吞嚥困難、聲音改變。
9. 消化系統：頻尿、尿液無法完全排空、便秘、失禁。
10. 性功能：陽萎、性慾喪失。

（三）常見檢查

1. 神經學檢查(Neurological examination)：包括意識狀態、十二對腦神經、運動功能及肌肉張力、反射功能、感覺功能、共濟或協調功能、行走功能或步態、不自主運動等檢查。
2. 眼底及視野檢查(Funduscopy examination & Visual Field)。
3. 腦脊髓液檢查(Cerebrospinal fluid；CSF)。
4. 誘發電位檢查：包括視覺誘發電位檢查、腦幹聽覺誘發電位檢查、體感誘發電位檢查。
5. 電腦斷層掃描(Computerized Tomography；CT)。
6. 核磁共振造影(Magnetic resonance imaging；MRI)：影像出現白質病灶，此檢查目前被認為最具價值臨床檢查方法。

（四）常見治療

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/11

針對此疾病目前無特定的治療方法。以症狀治療為主或促進神經保護，使其功能不再退化或延遲退化。針對各項症狀常見治療方式為藥物治療，分別有：

1. β 干擾素(Interferon beta 1a, Interferon beta 1b)：主要抑制自體 T-CELL 過度活躍來延遲病情惡化及減少復發的次數。
2. glatiramer acetate(GA)：對於無法耐受 β 干擾素替代治療，glatiramer acetate(GA)可直接保護神經，促進的神經再生，增殖和分化，並支持再髓鞘化。
3. 痙攣：使用肌肉鬆弛劑(baclofen、tizanidine 及 benzodiazepines)緩解，其 tizanidine 作用於中樞神經的 α_2 腎上腺素接受器(α_2 -adrenergic receptor)，經 Andrea & Stefanie(2015)實證研究具有鎮痛作用，適用多發性硬化症病人使用。
4. 疼痛：以解熱鎮痛類藥物治療，如：aspirin、acetaminophen 治療。
5. 疲勞：可考慮以 amantadine、pemoline 治療。
6. 視神經炎：以 steroids 治療，抑制炎症反應。
7. 膀胱功能異常：以 oxybutynin、propantheline 治療或置放導尿管來幫助排尿；長期可選擇間歇性導尿或膀胱訓練協助尿液排空。
8. 腎上腺皮質素(ACTH)。
9. 類固醇：如 Solu-Medrol(methyl-prednisolone)、Decadron(dexamethasone)、Prednisolone 治療急性發作。

(五) 護理問題

1. 無法有效呼吸／神經肌肉損傷。
2. 排尿困難／膀胱功能障礙。
3. 排便異常：便秘／固定不動。
4. 活動耐力不足／活動減少。
5. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙。
6. 自尊紊亂／對身體功能改變無法調適。
7. 個人因應能力失調／自我能力減低。

(六) 護理措施

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/11

1. 無法有效呼吸／神經肌肉損傷

- (1) 每班聽診呼吸音，評估分泌物的量及位置，並做紀錄。
- (2) 評估呼吸狀況，紀錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽、痰液的特性及是否有使用呼吸輔助肌。
- (3) 協助病人採取最佳姿勢以使肺部完全擴張，每 2 小時給予翻身，並給予背部扣擊及胸腔姿位引流之物理治療，促進痰液咳出。
- (4) 依醫囑給予蒸氣吸入，並教導咳痰技巧並衛教病人深呼吸及採深呼吸後再咳嗽。
- (5) 病人病情允許情況下鼓勵每日攝取 1500-2000ml 的液體，讓分泌物較易移除呼吸道。
- (6) 監測末梢血中氧氣飽和濃度，維持血氧飽和濃度 $>95\%$ ，觀察皮膚黏膜及四肢末梢有無發紺、缺氧情形。
- (7) 必要時進行抽吸，若病人有插管（如：氣切），予抽吸前後給予 100% 氧氣使肺部充氣，抽吸時間限制為 15 秒內。
- (8) 若血中氧氣濃度偏低，視情況給予氧氣吸入，輔助病人呼吸減少病人不適。

2. 排尿困難／膀胱功能障礙

- (1) 鼓勵病人放鬆、維護隱私，有助於膀胱肌肉的鬆弛。
- (2) 依病人個別性選擇適當的排尿容器，如尿壺、便盆、便盆椅。
- (3) 協助病人採取適當的排尿姿勢，並選擇適當的誘發排尿反射的方法，例如：開啟水龍頭造成水流聲、將病人的手置於水中、冰敷或輕壓腹部、或在其會陰處沖水等。
- (4) 藉由比較病人的輸出入量與其觸診有無膀胱膨脹的情形，以實際評估病人尿滯留之情形。
- (5) 若尿滯留情況持續存在，而病人的膀胱太過膨脹，則需予以導尿，並評估是否進行自我間歇導尿計劃。

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/11

- (6) 若病人成功排尿，則需檢查其餘尿，以避免餘尿過多易造成感染。
- (7) 記錄排尿量包含自解量及導尿量、排尿時間及病人反應。
- (8) 必要時安排相關尿路檢查。
- (9) 補充維他命 C 保持尿液呈酸性、每日喝 2000-3000cc 的水，以降低泌尿道感染機會。

3. 排便異常：便秘／固定不動

- (1) 鼓勵攝取高纖維飲食、粗糙的食物，以刺激腸蠕動增加排便。
- (2) 鼓勵病人每天攝取至少 2000cc 的水分，以維持糞便足夠的水分。
- (3) 衛教病人勿攝取過多精緻澱粉類食物，例如：蛋糕、麵包、餅乾等。
- (4) 衛教每天固定時間執行大便訓練，以建立規則排便習慣。
- (5) 教導腹部按摩技巧與注意事項。
- (6) 若病人允許下床可使用便盆椅或至廁所馬桶解便，以利病人排便。
- (7) 依醫囑給予軟便劑之使用。

4. 活動耐力不足／活動減少

- (1) 評估病人過去與目前的運動型態，以建立適合病人目前的運動型態。
- (2) 提供病人參與活動有關的資訊。
- (3) 協助病人確認會減少其活動耐力的因素。
- (4) 鼓勵病人從事他所能耐受的自我照顧、運動與休閒活動。
- (5) 教導當引起疼痛或疲累時，應暫停或減少活動。
- (6) 衛教病人採漸進式活動，避免突然之劇烈活動。
- (7) 適當評估病人能力範圍可完成之活動，勿強迫病人。
- (8) 每項活動中盡可能讓病人有足夠休息時間，以免體力不支。

5. 身體活動能力異常／神經肌肉障礙

- (1) 監測病人活動障礙部份之觸、壓、冷、熱、痛覺及肌肉力量，並隨時注意病程之進展。
- (2) 教導病人每日執行至少兩次（尤其起床及睡前，15 分鐘/次）全範圍之肌肉

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/11

拉長動作，以維持關節活動度，預防關節攣縮僵硬。

- (3)衛教病人採取漸進式活動並示範移動及轉位技巧。
- (4)協助病人從主動全關節運動漸進至功能性活動。
- (5)教導病人日常生活活動完成技巧及方法。
- (6)教導病人患側執行被動關節運動。
- (7)教導病人健側執行主動關節運動。
- (8)協助病人正確使用輔助器。
- (9)讓家屬及病人共同參與訂定活動計畫，並讓病人清楚目標與計畫內容。
- (10)盡可能讓病人獨立完成活動，適時給予鼓勵及讚美。
- (11)必要時依醫囑給予控制痙攣藥物，例如：Valium、Dantrium。

6.失去因應能力/壓力或疾病

- (1)對於各項檢查、治療前向病人說明，使病人有心理準備。
- (2)誠懇、專心、傾聽病人的需要，適時以同理心表達接受及支持。
- (3)維持培養良好的治療性人際關係，主動詢問病人的需要。
- (4)協同醫師與家屬及病人說明病情進展及治療方針，以增加病人信任及減輕壓力。
- (5)採用開放式問句，鼓勵病人主動表達內心之感受及對自己的看法。
- (6)對於病人的疑問，以誠懇、客觀、委婉的態度回答，並適時提供書面資料以供病人了解。
- (7)協助病人完成自己可自行完成之日常生活活動，包括洗臉、梳頭等，並給予正向回饋。
- (8)注意病人情緒表現是否於言談舉止間透露輕生意念，視情況會診身心科醫師與之會談。
- (9)鼓勵家屬多陪伴，對於病人的進步給予讚美，以強化病人的求生意志。
- (10)提供病人可詢問之管道與溝通方式，降低病人對未知的壓力。
- (11)針對高危險群病人應確保環境安全，避免危險物品擺放。

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/11

(七) 衛教指導

1. 日常生活注意事項：

- (1) 避免過熱的環境，因在較熱的環境中會加重症狀，故應避免三溫暖、泡熱水澡、溫泉、長時間熱敷等。
- (2) 避免危險的環境，以免造成意外傷害。
- (3) 建議病人攝取較容易吞嚥的食物或依語言治療師的建議攝取食物，以避免吞嚥或咀嚼困難造成吸入性肺炎或噎咳。
- (4) 鼓勵病人執行規律運動：缺乏運動會引起關節攣縮、便秘等問題。
- (5) 衛教病人如何對抗便秘與大小便失禁：
 - A. 多攝取全穀類或全麥食品與蔬果及水份。
 - B. 以新鮮或乾燥水果、沙拉或全麥餅乾當點心。
 - C. 少喝咖啡、茶、可樂與酒類飲料。
 - D. 每天喝水 1500-2000cc，睡覺前 3 個小時不要喝水。
 - E. 給病人充足時間排便，養成每日固定時間執行排便。
 - F. 按時協助腹部按摩，並記錄排便量、時間、性質。

2. 舒解壓力：

- (1) 鼓勵病人以傾訴來紓解壓力：和值得信任的朋友、諮詢專家或支持團體分享您的想法、感覺與擔憂。
- (2) 引導病人將氣憤表達出來：以不責備他人的方式表達氣憤。然後做幾次深呼吸來恢復平靜。
- (3) 衛教病人規律運動：身體狀況較好的時候，也比較能夠對抗壓力。
- (4) 不影響病房安靜度情形下，提供病人耳機或收音機，聆聽輕音樂促進肢體放鬆及降低心理壓力。
- (5) 不要勉強病人，盡可能採陪伴或漸進式溝通。
- (6) 必要時可轉介心理師或身心專科醫師協助。

3. 性問題：

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/11

- (1)衛教可嘗試各式各樣不同的姿勢，讓自己與伴侶都能感到愉悅與滿足。
- (2)衛教如果性行為姿勢非常困難，利用按摩、相擁、愛撫或其他肢體接觸也可以維持親密感。
- (3)衛教嘗試可以讓性愛有愉悅感與滿足感的情趣用品。
- (4)衛教確實無法進行性行為時，嘗試找出可增進情緒與生理性愉悅並能維持親密感的方法。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 陳怡君、葉美杞、吳玉欣(2020)・運用醫病共享決策於一位初診斷多發性硬化症患者之護理經驗・高雄護理雜誌，37(3)，68-81。
- (二) 謝佩吟、賴美玉(2021)・一位多發性硬化症病人成功脫離呼吸器護理經驗・高雄護理雜誌，38(2)，80-92。
- (三) 郭嘉琪、邱禹璇、呂玟燁、吳幸宜、陳沛綺、呂芷彤、辜漢章(2025)・阻力訓練於多發性硬化症疲憊成效・護理雜誌，_72(4) 78-87
- (四) Levasseur, V. A., Xiang, B., Salter, A., Yablonskiy, D. A., & Cross, A. H. (2022). Stronger Microstructural Damage Revealed in Multiple Sclerosis Lesions With Central Vein Sign by Quantitative Gradient Echo MRI. *Journal of central nervous system disease*, 14,

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/11

七、附件

(略)

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定。	97 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.31	2.1	說明內容部份修辭及修正標點符號。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	1. 第三項說明內容修正並新增加入實證資料；實證來源依據 Andrea, R., & Stefanie, K. (2015)、Gulick, E. E. (2010)。 2. 參考資料更新新增五年內文獻。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 第三項第(二)、(六)、(七)項目說明內容部份修正及新增。 2. 將參考文獻新增於內文中。 3. 新增第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	1. 第三項第(一)、(二)目部份內容增修。 2. 新增第三項第(六)目之 2(8)及 6(12)內容。 3. 新增第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目之 2 視力喪失更改為嚴重者甚至失明、之 7 新增 60-80%； 3. 第三項第四目之 1 新增過度活躍來延遲病情惡化及減少復發的次數、之 9 新增治療急性發作。 4. 第三項第六目之 2(9) 補充維他命 C 保持尿液呈酸性、每日喝 2000-3000cc 的水，以降低泌尿道感染機會。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。

主題名稱	多發性硬化症	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A08	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
		5. 第三項第六目之 5(2)新增文字說明(尤其起床及睡前，15 分鐘/次)，及預防關節攣縮僵硬。 6. 第六項第五、七目新增參考資料。	
108.09.23	3.5	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.6	第三項第二目及第二目之 6 文字修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.07	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.7	1. 第三項第五、六目護理問題修訂。 2. 第六項參考文獻增減。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.10.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	3.8	1.第三項第(二)目內文文字修訂。 2.第三項第(六)目第 6 點刪除、第 7 點標題修訂 3.第六項參考文獻增減。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。